

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

УДК:618.19-006.6.771

А.Ж. Жылкайдарова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Оценка динамики показателей заболеваемости и смертности от рака молочной железы в Казахстане за 2004-2014 годы

Аннотация. Дана оценка показателей заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) за последние 10 лет. Территориальные, временные и повозрастные особенности РМЖ изучали с помощью интенсивных и стандартизованных по возрасту показателей на 100 тыс женского населения. В Республике Казахстан показатели заболеваемости колеблются от 27,4‰ (Южно-Казахстанская область) до 59,5‰ (г.Алматы) женского населения, приведенного по возрастной структуре к мировому стандарту World. В 2004 году показатели заболеваемости составили 36,1‰, в 2014 году – 43,0‰. При анализе динамики в разрезе стадий отмечается увеличение частоты выявления РМЖ в первой и второй стадии за период с 2004 по 2014 годы.

Ключевые слова: рак молочной железы, заболеваемость, смертность, Республика Казахстан.

Согласно базе данных GLOBOCAN, число заболевших злокачественными новообразованиями молочной железы в 2012 году составило 1 671 149 женщин, число умерших – 521 907 женщин. Среднемировая заболеваемость составила 43,1‰ – 1 место в структуре онкозаболеваемости, смертность 12,9‰, 2 место в структуре онкосмертности. Отношение смертности к заболеваемости составляет 29,9%.

В большинстве стран мира злокачественные новообразования молочной железы занимают первое место в структуре онкозаболеваемости. Уровни заболеваемости (на 100 000 жителей, приведенных по возрастной структуре к мировому стандарту World) по странам колеблются: в европейском регионе от 48,7‰ в Литве до 104,5‰ во Франции и 105,0‰ в Дании (регион очень высокой заболеваемости), в азиатско-тихоокеанском регионе – от 22,1‰ в Китае до 86,0‰ в Австралии. Очень высокие уровни заболеваемости отмечаются в США (92,9‰) и Канаде (79,8‰).

В странах СНГ отмечаются колебания от низкой заболеваемости (Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан) до средней (Российская Федерация, Украина). Только Казахстан и Беларусь относятся к странам с высоким уровнем заболеваемости (таблица 1).

Оценочные показатели ВОЗ, GLOBOCAN 2012 превышают реальные показатели Электронного регистра онкологических больных Республики Казахстан (63,0‰ и 45,5‰). Возможно, ожидаемый рост заболеваемости вследствие внедрения скрининга еще не достигнут.

Показатели смертности от злокачественных новообразований молочной железы имеют значительно меньшие отличия по странам, но при этом отношения показателей смертности к заболеваемости существенно различаются. Причем четко прослеживается зависимость от состояния экономической ситуации – в промышленно развитых странах показатель отношения смертности к заболеваемости ниже, чем в менее развитых. Например, в Нидерландах, Дании, Франции, имеющих очень высокие показатели заболеваемости (100‰ и выше), отношение смертности к заболеваемости составляет 15-18%, в Словакии, Польше и Китае – 22-26%, Индии – 49,2%.

В Казахстане среди стран СНГ данный показатель один из самых низких: по сведениям GLOBOCAN 28,7%, по уточненным данным канцер-регистра – 35,4-35,8%. По уточненным данным Казахстан незначительно опережает Российскую Федерацию и Узбекистан, уступая Азербайджану и Беларуси. Эти различия служат подтверждением высокой значимости проблемы улучшения результатов лечения.

В структуре всех злокачественных новообразований в Республике Казахстан доля злокачественных новообразований молочной железы в 2014 году составила 12,1% (1 ранговое место с 2011 года).

Таблица 1- Заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы и смертность от них в отдельных странах мира в 2012 году (на 100 000 женского населения, мировой стандарт World, данные GLOBOCAN 2012)

Страны	Заболеваемость	Смертность	Отношение смертности к заболеваемости (оба пола),%
Казахстан*	63,0	18,1	28,7
Казахстан**	45,5	16,3	35,8
Казахстан***	43,5	15,4	35,4
Азербайджан	25,4	8,6	33,9
Беларусь	45,9	14,2	30,9
Кыргызстан	27,3	11,2	41,0
Российская Федерация	45,6	17,2	37,7
Узбекистан	27,1	10,6	39,1
Украина	41,3	18,4	44,6
Великобритания	95,0	17,1	18,0
Германия	91,6	15,5	16,9
Дания	105,0	18,8	17,9
Латвия	52,1	17,6	33,8
Литва	48,7	16,3	33,5

Нидерланды	99,0	18,0	18,2
Польша	51,9	13,8	26,6
Словакия	57,5	13,1	22,8
Финляндия	89,4	13,6	15,2
Франция	104,5	16,4	15,7
Швейцария	83,1	16,4	19,7
Швеция	80,4	13,4	16,7
Индия	25,8	12,7	49,2
Китай	22,1	5,4	24,4
Корея	52,1	6,1	11,7
Япония	51,5	9,8	19,0
Австралия	86,0	14,0	16,3
Бразилия	59,5	14,3	24,0
Канада	79,8	13,9	17,4
США	92,9	14,9	16,0

Примечания: * по данным ВОЗ, GLOBOCAN 2012
 ** по данным ЭРОБ РК, интенсивные (грубые) показатели
 *** по данным ЭРОБ РК, стандартизованные показатели

Анализ интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости (рисунок 1) свидетельствует о снижении частоты выявления новых случаев заболевания. За 2004-2014 годы отмечается неуклонная тенденция роста первичной заболеваемости с 39,1‰ до 46,0‰ (интенсивные показатели) и с 38,2‰ до 43,0‰. Причем заметный рост заболеваемости отмечается с 2011 года, когда внедрены европейские стандарты скрининга в Казахстане, позволившие повысить качество программы ранней диагностики. Коэффициенты детерминации R^2 интенсивных и стандартизованных показателей имеют высокие уровни, что свидетельствует об устойчивом характере процесса.

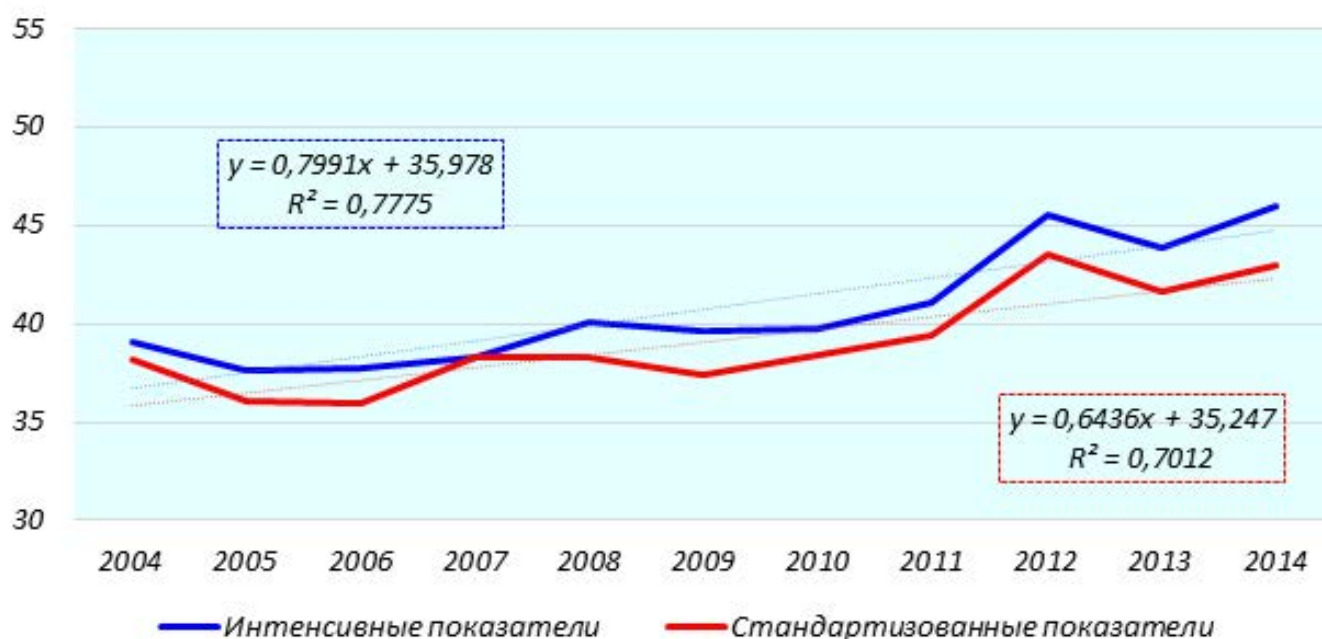


Рисунок 1 – Динамика интенсивных и стандартизованных WHO World показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы на 100 000 женского населения Республики Казахстан за период 2004-2014 годы

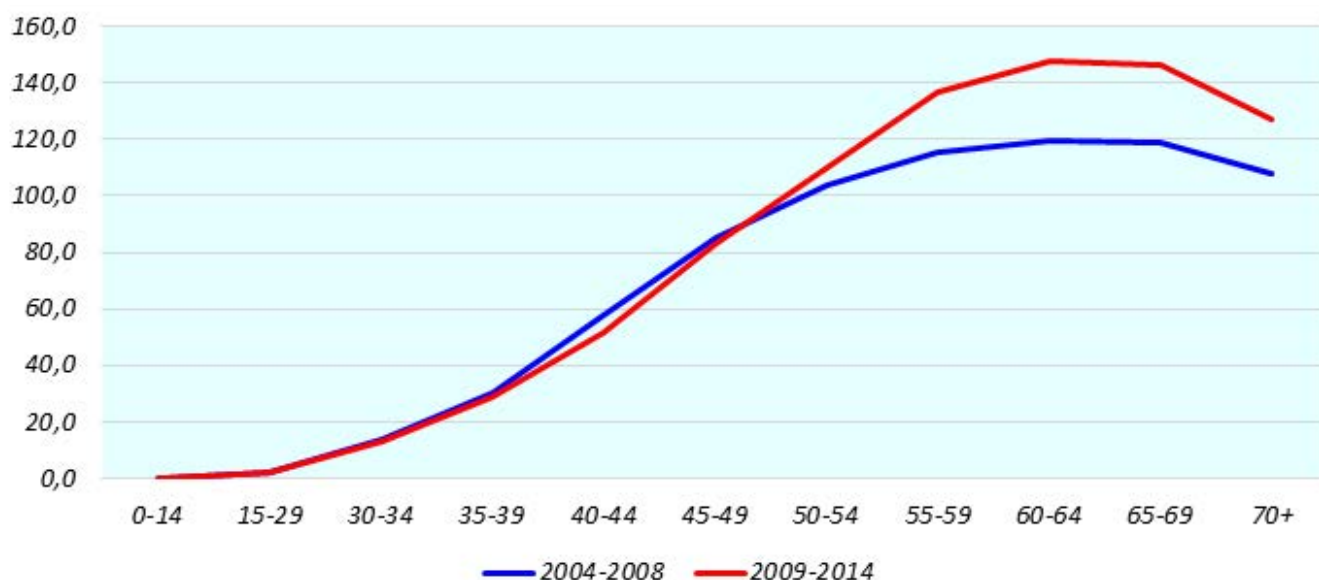


Рисунок 2 – Возрастные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы населения Республики Казахстан (средние показатели на 100 000 женского населения соответствующего возраста за 2004-2008 и 2009-2014 годы)

Анализ возрастной заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы показывает увеличение ее частоты, начиная с 35 лет, с неуклонным ростом и максимальными показателями в возрасте 60-69 лет (рисунок 2). При сравнении показателей двух временных периодов – 2004-2008 и 2009-2014 годы – в последние 6 лет отмечается прирост заболеваемости в возрастной группе 50 лет и старше, что обусловлено проведением скрининга рака молочной железы в целевой возрастной группе 50-60 лет и оснащением в достаточном количестве организаций ПМСП маммографами. Темп прироста к базовой заболеваемости 2004-2008 годов составляет от 6,4% в возрастной группе 50-54 года и 18,5% в возрасте 55-59 лет до 23,4% в возрасте 60-69 лет.

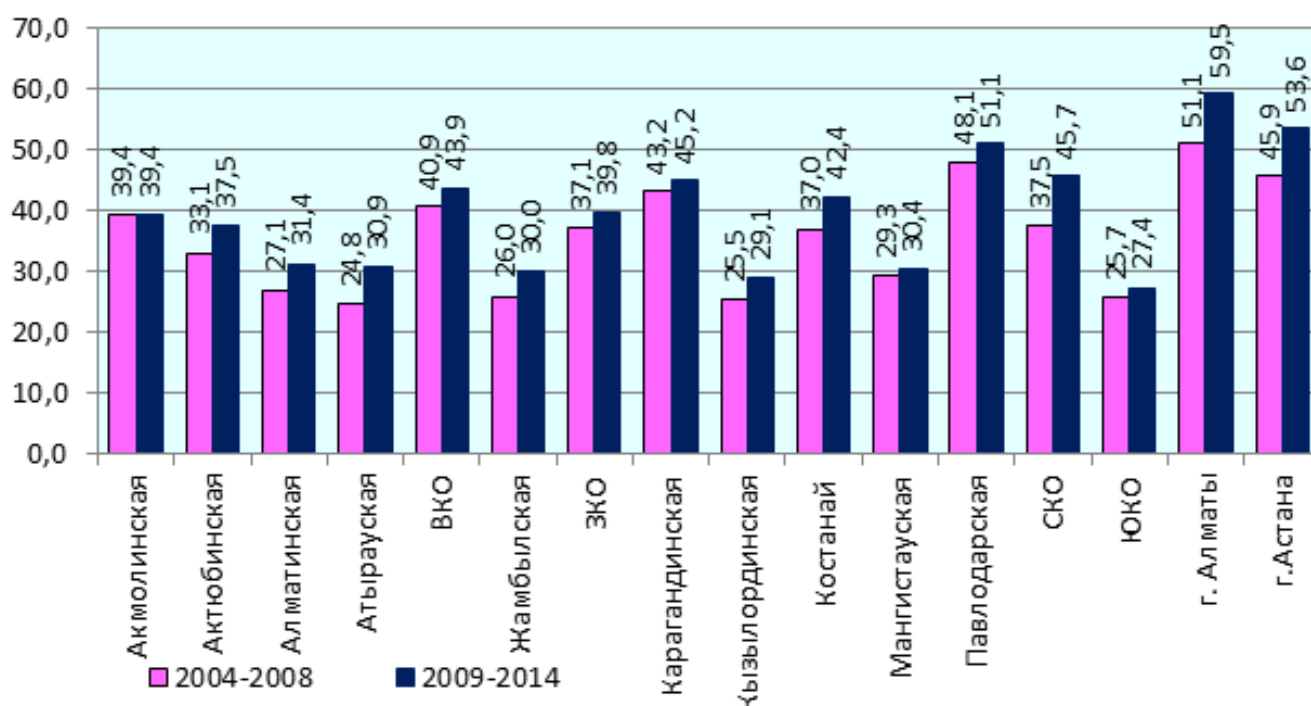


Рисунок 3 – Территориальные уровни заболеваемости населения Республики Казахстан злокачественными новообразованиями молочной железы (стандартизованные показатели WHO World на 100 000 женского населения, за 2004-2008 и 2009-2014 годы)

Среди административных территорий самая высокая заболеваемость регистрируется среди жителей гг. Алматы, Астаны, Павлодарской области – среднегодовая заболеваемость за последние 6 лет превышает 50‰. К регионам со средним уровнем заболеваемости (по критериям ВОЗ GLOBACAN – 33,9-45,8‰) относятся Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

При анализе территориальных особенностей заболеваемости отмечается повсеместный рост заболеваемости в 2009-2014 годах, за исключением Акмолинской области, где отсутствует динамика роста заболеваемости, несмотря на проведение скрининга

рака молочной железы. Наиболее высокий прирост заболеваемости отмечается в Атырауской (24,7%) и Северо-Казахстанской (21,9%) областях, а также в гг.Алматы, Астана, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях – от 16,9% до 13,3%.

Начиная с 2006 года, в связи с широким использованием маммографии и в дальнейшем с проведением программы скрининга, отмечается неуклонный рост удельного веса ранних стадий злокачественных новообразований молочной железы со средним темпом прироста 3,2%. Увеличение удельного веса I-II стадий в последние годы происходит в основном за счет снижения удельного веса III стадий (рисунок 4).

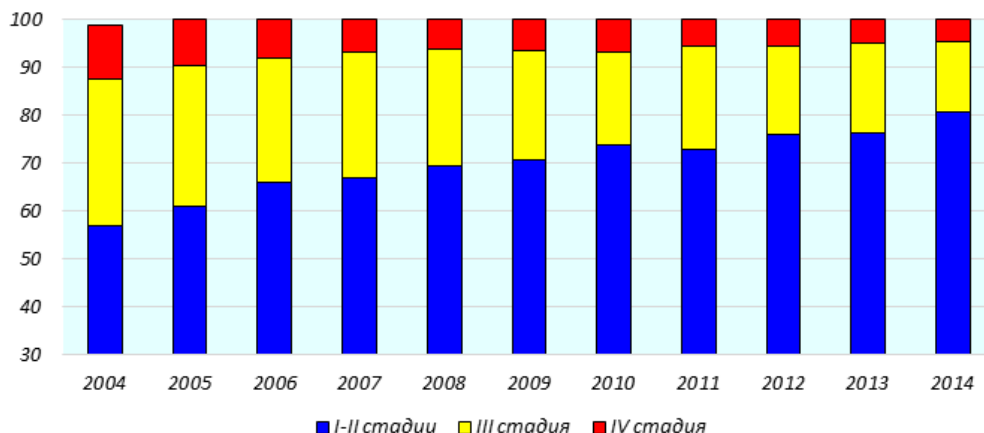


Рисунок 4 – Удельный вес I-II, III и IV стадий вновь зарегистрированных случаев злокачественных новообразований молочной железы женского населения Республики Казахстан (%)

В таблице 2 представлены основные статистические показатели, характеризующие состояние онкологической помощи пациентам со злокачественными новообразованиями молочной железы. Число вновь зарегистрированных случаев увеличилось по сравнению с 2008 годом на 26,9% и составило в 2014 году 4 142 случая. Практически все случаи были подтверждены морфологически (96,1%). Удельный вес I-II стадий увеличился в 2014 году на 15,5% по сравнению с 2008 годом и составил 80,6%. Кроме того, отмечается снижение удельного веса IV стадии на 23% (4,7% в 2014 году против 6,1% в 2008 году). Одногодичная летальность снизилась почти на треть (27,5%), что говорит об улучшении своевременной диагностики злокачественных новообразований молочной железы. Число пациентов, получивших комплексное лечение снизилось, однако не является показателем ухудшения качества оказания онкологической помощи – увеличилось количество пациентов с малыми формами рака, для которых радикальным методом лечения является хирургический или комбинированный.

Таблица 2 – Основные статистические показатели. Злокачественные новообразования молочной железы

Показатель	2008	2014		
Число впервые выявленных случаев	3263	4142	Получили лечение по радикальной программе (% из числа вновь заболевших, получивших комплексное лечение)	47,8 41,7
Заболеваемость на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель)	40,1	46,0	Пятилетняя выживаемость (все стадии в%)	50,7 51,3
Заболеваемость на 100 000 населения (стандартизованный WHO World показатель)	38,3	43,0	Умерло от злокачественных новообразований молочной железы	1420 1346
Удельный вес I-II стадий (% к вновь выявленным случаям)	69,8	80,6	Смертность на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель)	17,5 15,0
Удельный вес IV стадии (% к вновь выявленным случаям)	6,1	4,7	Смертность на 100 000 населения (стандартизованный WHO World показатель)	16,5 13,8
Число впервые выявленных при скрининге	296	704	Отношение смертности и заболеваемости в% (интенсивные показатели)	43,6 30,0
Выявляемость скрининга (% к числу осмотренных)	0,07	0,18	Отношение смертности и заболеваемости в% (стандартизованные показатели)	43,1 32,1
Подтверждено морфологически (% к выявленным случаям)	95,2	96,1	Число пациентов, состоящих на учете на конец года	22965 29796
Прожили менее одного года с момента установления диагноза из числа зарегистрированных в предыдущем году (одногодичная летальность в%)	9,1	6,6	Из них состоящих на учете 5 лет и более	11644 15288

Анализ интенсивных и стандартизованных показателей смертности свидетельствует о снижении смертности от заболевания. За 2004-2014 годы смертность (интенсивные показатели) имеет стабильный характер с тенденцией к снижению. Интенсивные показатели изменились с 16,5‰ в 2008 году до 15,0‰ в 2014 году, стандартизованные соответственно с 16,0‰ до 13,8‰. Коэффициент детерминации стандартизованных показателей ($R^2 = 0,7204$) выше, чем коэффициент интенсивных показателей, и свидетельствует об устойчивости снижающегося тренда (рисунок 5).

Об этом также свидетельствует увеличение пятилетней выживаемости и рост пациентов, состоящих на учете 5 и более лет, с 11644 в 2008 году до 15288 в 2014 году.

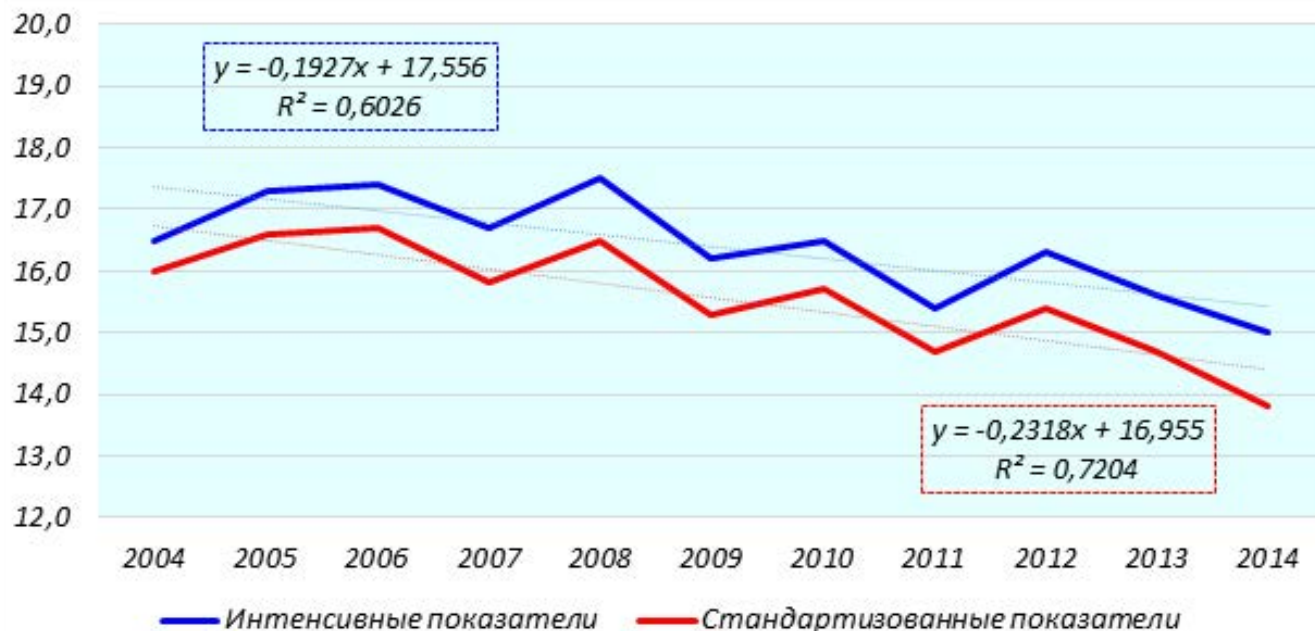


Рисунок 5 – Динамика интенсивных и стандартизованных WHO World показателей смертности от злокачественных новообразований молочной железы на 100 000 женского населения Республики Казахстан за период 2004-2014 годы

При стабилизации показателей смертности и устойчивом росте заболеваемости отмечается снижение показателя отношения смертности к заболеваемости с 46,2% в 2006 году до 32,6% в 2014 году при высоком уровне коэффициента детерминации $R^2 = 0,8138$ (рисунок 6).

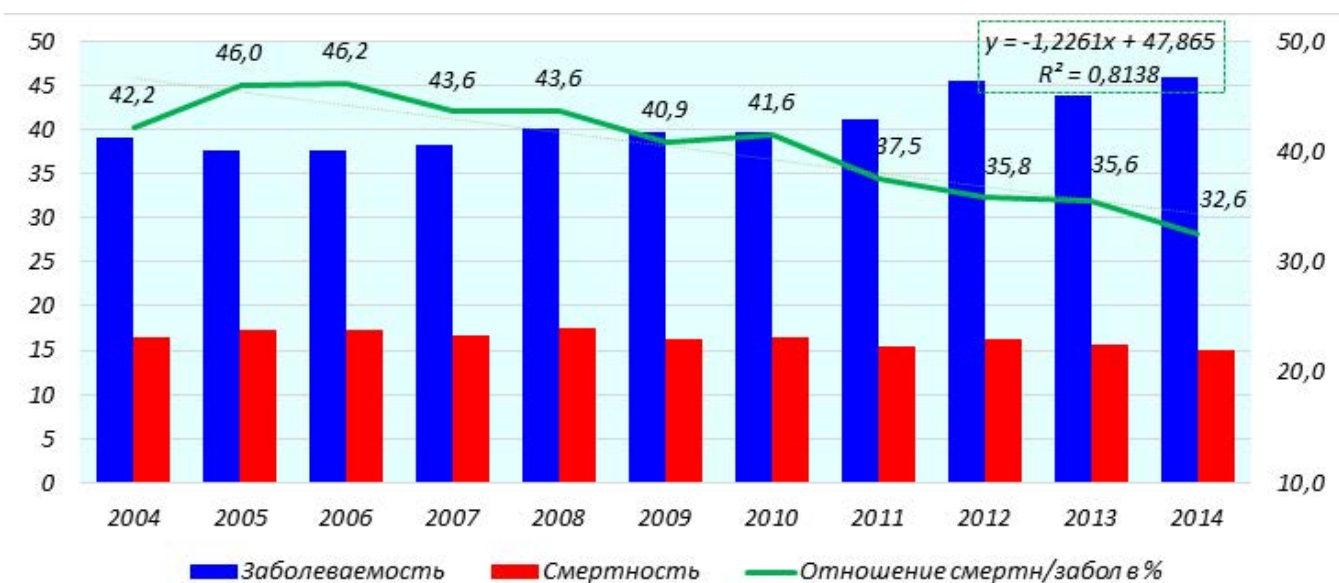


Рисунок 6 – Злокачественные новообразования молочной железы: заболеваемость, смертность (грубые интенсивные показатели), отношение показателей смертности к заболеваемости (%) за 2004-2014 годы

Устойчивое снижение показателя отношения смертности к заболеваемости (как грубых интенсивных, так и стандартизованных WHO World показателей) демонстрирует успехи программы ранней диагностики злокачественных новообразований молочной железы, которая начала внедряться с 2006 года и сложилась в программу скрининга с 2008 года. Однако только с 2011 года внедрена двойная читка маммограмм, введены другие индикаторы эффективных скрининговых программ, включая создание специализированных консультативно-диагностических отделений на базе онкологических диспансеров, осуществляющих не только организационно-методические, но и функции мониторинга.

В таблице 3 представлены результаты реализации скрининга рака молочной железы за 2011-2014 годы.

Охват участников скринингом в разные годы был разным, однако в первые годы внедрения скрининга охват не был подкреплен контролем качества. С 2011 года внедрены международные требования качества скрининга – двойная читка маммограмм, архивирование на базе онкологических диспансеров, что позволило отслеживать реальное количество обследуемых

женщин. В настоящее время ежегодный охват женского населения скринингом составляет 380-390 тысяч женщин целевой группы в возрасте от 50 до 60 лет, что приблизительно соответствует 70% от числа подлежащего населению. Уровень выявляемости злокачественных новообразований молочной железы вырос от 0,10% от числа обследованных женщин до 0,18%. Самый высокий уровень выявляемости в Акмолинской, Костанайской областях и г.Алматы (0,24-0,26%). В рамках скрининга ежегодно выявляется от 438 до 704 случаев злокачественных новообразований молочной железы, т.е. от 12,4% до 17% от всех вновь регистрируемых случаев. Уровень ранней диагностики составляет более 85%. В 2014 году из 704 случаев рака молочной железы 91,3% были выявлены в I-II стадии процесса.

Реализация Государственной программы «Саламатты Қазақстан» и Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан позволили провести дооснащение аналоговых маммографов амбулаторно-поликлинических организаций цифровыми установками, тем самым увеличив резерв совершенствования ранней диагностики злокачественных новообразований молочной железы

Таблица 3 - Результаты проведения скрининга рака молочной железы, 2011-2014 годы

Области	Число обследованных женщин				Число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований молочной железы				Выявляемость злокачественных новообразований молочной железы, % к числу охвата				Удельный вес I-II стадий, % от числа выявленных случаев			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Республика Казахстан	455745	459816	379903	386112	438	633	616	704	0,10	0,14	0,16	0,18	85,8	86,1	84,7	91,3
Акмолинская	25337	25780	18118	19867	24	15	33	49	0,09	0,06	0,18	0,25	100,0	80,0	60,6	75,5
Актюбинская	20483	20570	20036	19254	20	27	27	32	0,10	0,13	0,13	0,17	100,0	92,6	85,2	87,5
Алматинская	63448	60927	27500	41648	49	45	31	48	0,08	0,07	0,11	0,12	89,8	71,1	77,5	93,8
Атырауская	12104	12571	12604	11827	16	11	19	20	0,13	0,09	0,15	0,17	100,0	81,8	94,7	100,0
Восточно-Казахстанская	42875	41127	36853	34997	48	57	65	69	0,11	0,14	0,18	0,20	72,9	84,2	89,2	92,8
Жамбылская	27107	26501	23172	22443	14	32	19	27	0,05	0,12	0,08	0,12	92,9	90,6	100,0	100,0
Западно-Казахстанская	16598	16616	17185	16597	25	41	43	24	0,15	0,25	0,25	0,14	100,0	100,0	95,3	100,0
Карагандинская	45998	47540	33317	32692	84	73	77	50	0,18	0,15	0,23	0,15	63,1	86,3	89,7	92,0
Костанайская	27824	27936	22014	20240	16	47	36	48	0,06	0,17	0,16	0,24	93,8	78,7	77,8	85,4
Кызылординская	13110	13569	14455	13976	12	17	13	23	0,09	0,13	0,09	0,16	75,0	100,0	84,6	91,3
Мангистауская	7555	9478	8724	10359	1	1	21	21	0,01	0,01	0,24	0,20	100,0	100,0	85,7	95,2
Павлодарская	13846	18484	13239	21407	19	43	33	44	0,14	0,23	0,25	0,21	100,0	95,3	97,0	88,6
Северо-Казахстанская	20808	20261	18406	18167	51	44	41	37	0,25	0,22	0,22	0,20	100,0	93,2	95,1	100,0
Южно-Казахстанская	58517	62360	57352	55146	36	71	59	76	0,06	0,11	0,10	0,14	91,7	95,8	79,7	92,1
г.Алматы	48247	44762	47934	38415	19	74	63	100	0,04	0,17	0,13	0,26	84,2	94,6	77,8	97,0
г.Астана	11888	11334	8994	9077	4	35	36	36	0,03	0,31	0,40	0,40	50,0	80,0	72,3	75,0

ТҰЖЫРЫМ**А.Ж.Жылқайдарова**

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

**2004-2014 жж аралығында Қазақстан Республикасындағы
сүт безінің қатерлі ісігінен ауыру және өлім көрсеткіші**

Соңғы 10 жыл аралығында сүт безінің қатерлі ісігімен (СБҚІ) ауру көрсеткіші бағаланды. СБҚІ аймақтық, уақтылы және жастық ерекшеліктерін 100 мың әйелге шаққанда жастық интенсивті және стандартизацияланған көрсеткішпен есептелді. World әлемдік стандарты көрсеткішімен сәйкестендіргенде Қазақстан Республикасында ауыру көрсеткіші әйелге шаққанда 27%000-ден (Оңтүстік Қазақстан облысы) 59,5%000 дейін (Алматы қ.) құрайды. 2004 ж. ауру көрсеткіші 36,1%000, 2014 ж. 43,0%000. 2004-2014 жж. аралығында СБҚІ стадиялық анализінде бірінші және екінші стадияның анықталуы жоғарылауда.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, ауыру, өлім, Қазақстан Республикасы.

SUMMARY**A.Zhylkaidarova**

Kazakh Institute of Oncology and Radiology

**The estimation of incidence and mortality from breast cancer
in the Republic of Kazakhstan for 2004-2014**

The estimation of the breast cancer (BC) epidemiology in Kazakhstan for 10 years (from 2004 to 2014) was given. Territorial, time and age-specific characteristics of BC were studied using intense and age-standardized to 100 thousand female population. In the Republic of Kazakhstan incidence rates range from 27.4%000 (South Kazakhstan oblast) to 59.5%000 (Almaty city) female population. In 2004, incidence rates were 36.1%000, in 2014 - 43.0%000. In the analysis of BC in the context of the stages was marked the increase of detection rate on the first and the second stages of disease from 2004 to 2014.

Keywords: breast cancer, incidence, mortality, the Republic of Kazakhstan